akute Appendizitis Dr Heiko mit Dr Zehra Betul 26.03.2026

Patientenvorstellung (konj 1)

Herr Doktor Oberarzt, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde sie Ihnen gerne vorstellen.

Es handelt sich um die **36-jährige Frau Elena Stückmann**. Sie ist **1,80 m groß** und wiegt **60 kg**.

Frau Stückmann stellte sich heute bei uns wegen seit **12 Stunden bestehenden**, **dauerhaften**, **langsam aufgetretenen**, **drückenden Schmerzen im rechten Unterbauch** vor. Sie berichtete, dass die Schmerzen **am Umbilikus angefangen haben** und **nach etwa 6 Stunden in den rechten Unterbauch gewandert sind**. Die Schmerzen lägen bei **6 von 10 auf der Schmerzskala**.

Die Schmerzen würden sich **verschlechtern, wenn man auf den rechten Unterbauch drückt**. Die Schmerzen seien **ohne Ausstrahlung**.

Begleitend bestünden **Nausea ohne Emesis**. Außerdem habe die Patientin **Fieber**, sie habe es **vor 2 Stunden oral gemessen** und dabei **38,3 Grad** festgestellt. Seit gestern leide sie unter **Inappetenz** und **schmerzbedingter Insomnie**. Sonst sei die vegetative Anamnese unauffällig. Die **Miktion** sei unauffällig, und die **Defäkation** sei ebenfalls unauffällig. Der letzte Stuhlgang sei **vor ungefähr einem Tag** gewesen.

Die Patientin leide an einer **Herzrhythmusstörung**. Diese sei **im Alter von 23 Jahren festgestellt worden**, und sie habe deswegen einen **Herzschrittmacher** bekommen. Seitdem sei alles in Ordnung. Außerdem leide sie an einer **Fruktoseintoleranz**, die **diätetisch behandelt** werde.

Im Alter von **10 Jahren** sei bei Frau Stückmann **eine linksseitige Leistenhernienoperation** durchgeführt worden. Außerdem sei im Alter von **20 Jahren** wegen einer **linksseitigen Sprunggelenkfraktur nach einem Fahrradunfall** eine Operation durchgeführt worden.

Die Patientin nehme **keine regelmäßigen Medikamente** ein. Sie sei **Nichtraucherin** und trinke **gelegentlich Alkohol**, ungefähr **2 Gläser Wein am Wochenende**. Sie habe **keinen Kontakt mit Drogen**. Außerdem treibe sie **regelmäßig Sport**. Sie sei **Sportlehrerin** und bewege sich deshalb jeden Tag.

Sie sei **vollständig geimpft**. Bis auf eine **Spanien- und Italienreise** sei die Reiseanamnese unauffällig.

Der Vater von Frau Stückmann sei **im Alter von 66 Jahren an einem Myokardinfarkt verstorben**. Außerdem habe er an einem **Prostatakarzinom** gelitten. Die Mutter leide an einem **Ovarialkarzinom**, das mit **Operation und Chemotherapie** behandelt worden sei. Die Schwester leide an einer **Hypothyreose**.

Frau Stückmann sei **verheiratet** und habe **eine gesunde 5-jährige Tochter**. Sie bekomme ihre Menstruation normalerweise regelmäßig, aber die **letzte Menstruation** habe sie **vor 7 Wochen** gehabt. Deshalb sei eine **Schwangerschaft theoretisch möglich**. Sie verhüte mit einer **Spirale**.

Die anamnestischen Angaben sprechen am ehesten für eine **Appendizitis**. Differentialdiagnostisch kommen eine **Extrauteringravidität**, eine **Ovarialtorsion** oder ein anderer **gynäkologischer Prozess** in Betracht.

Als weiteres vorgehen würde ich eine **körperliche Untersuchung**, **Laboruntersuchungen**, eine **Abdominalsonografie** sowie gegebenenfalls ein **gynäkologisches Konsil** veranlassen.

🩺 Vollständige Anamnese – korrigierte Endversion (FSP-Niveau)

👩‍⚕️ Patientendaten

- **Name:** Elena Stückmann
- **Alter:** 36 Jahre
- **Geburtsdatum:** 12.03.1990
- **Größe/Gewicht:** 180 cm / 60 kg
- **Beruf:** Sportlehrerin
- **Familienstand:** Verheiratet, 1 Tochter (5 Jahre, gesund)

⚠️ Aktuelle Anamnese

Die Patientin stellt sich mit seit **12 Stunden bestehenden Bauchschmerzen** vor.

- **Beginn:** langsam
- **Lokalisation:**
  - initial **periumbilikal**
  - später **rechter Unterbauch (Fossa iliaca dextra)**
- **Charakter:** dauerhaft, drückend
- **Intensität:** 6/10 (VAS)
- **Ausstrahlung:** keine

🔎 Verstärkung / Linderung

- **Verstärkung:** Druck auf den Bauch, enge Kleidung
- **Linderung:** Ruhe, Rückenlage

🤢 Begleitsymptome

- **Nausea ohne Emesis**
- **Fieber:** 38,3 °C (oral, vor 2 Stunden gemessen)
- **Inappetenz**

- **Schlafstörung** (schmerzbedingt)

❌ Verneint

- Kein Erbrechen
- Kein Schüttelfrost / Nachtschweiß
- Keine Herzrhythmusstörungen aktuell
- Keine Hautveränderungen
- Keine Harn- oder Stuhlprobleme

🚻 Vegetative Anamnese

- **Miktion:** unauffällig
- **Defäkation:** unauffällig, letzter Stuhlgang vor ~1 Tag
- **Gewicht:** stabil

🧬 Eigenanamnese

- **Herzrhythmusstörungen** mit Synkopen →
  → **Herzschrittmacher seit dem 23. Lebensjahr**, aktuell beschwerdefrei
- **Fruktoseintoleranz**, diätetisch gut eingestellt

🔪 Operationsanamnese

- **Leistenhernien-OP links** (10. LJ)
- **Distale Fibulafraktur links** (Außenknöchel) nach Fahrradunfall → operativ versorgt (Osteosynthese)

💊 Medikamentenanamnese

- Keine Dauermedikation
- Keine Bedarfsmedikation

⚠️ Allergien

- **Nicht erfragt → Anamnese hier unvollständig!**
- Nur **Fruktoseintoleranz (Unverträglichkeit)** bekannt

🚬 Noxen

- **Nikotin:** nein
- **Alkohol:** gelegentlich (≈ 2 Gläser Wein/Wochenende)
- **Drogen:** nein

🏃 Sozialanamnese

- Sportlehrerin → **regelmäßige körperliche Aktivität**
- Zusätzlich gelegentlich Joggen

🌍 Reise- & Impfstatus

- **Reisen:** Spanien & Italien (keine Fernreisen)
- **Impfungen:** vollständig laut Patientin

👪 Familienanamnese

- **Vater:**
  - Myokardinfarkt († mit 66 Jahren)
  - Prostatakarzinom (operiert + bestrahlt)
- **Mutter:**
  - Ovarialkarzinom (OP + Chemotherapie, aktuell stabil)
- **Schwester:**
  - Hypothyreose

👩‍🤰 Gynäkologische Anamnese

- **Menstruation:** normalerweise regelmäßig
- **Letzte Periode:** vor 7 Wochen → überfällig
- **Schwangerschaft:** möglich
- **Verhütung:** Spirale (IUD)
- **Fluor:** keiner
- **Dysmenorrhö:** keine

🧠 Verdachtsdiagnosen

🔴 Hauptdiagnosen

1. **Akute Appendizitis** (typischer Verlauf!)
2. **Extrauteringravidität (EUG)** ⚠️ (muss ausgeschlossen werden!)

🟡 Weitere DD

- Ovarialtorsion
- Ovarialzyste
- Ileus
- (weniger wahrscheinlich: Cholezystitis, Divertikulitis)

🏥 Weiteres Vorgehen

- Körperliche Untersuchung
- Schwangerschaftstest
- Labor (CRP, Leukozyten etc.)
- Abdomensonografie

Soru:
Ja, guten Abend. Zum Beispiel in der Prüfung der Patient oder die Patientin hat praktisch. Was ist der Unterschied zwischen Allergien oder Unverträglichkeit. Unverträglichkeiten wie. Können deutlich und kurze Antwort geben, können wir.
Also die Patientin fragt sie das oder der Prüfer.

Patientin fragt. Bei der Anamnese erheben. Zum Beispiel: wie fragen: Haben Sie, oder ist Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Der Patient fragt uns.

Heiko'nun cevabı:

Ja, das ist manchmal, glaube ich, etwas schwierig, dieses genau zu differenzieren.
Wenn jetzt jemand sagt, ich vertrage kein frisches Brot.
Ja, also, das sind viele Leute, die ein frisches Brot, frischgebackenes Brot nicht gut vertragen, die müssen das Brot 2 Tage liegen lassen, oder einen Tag, und dann vertragen sie es besser.
Weil sie bekommen davon Magenschmerzen oder Bauchschmerzen oder starke Blähungen, dann würde ich sagen, ist das eine Unverträglichkeit.
Ja, es ist keine Allergie.
Wenn aber die Leute sagen, wenn ich einen Apfel esse, und ich bekomme einen Ausschlag im Mund, Bläschen ja im Mund oder die Schleimhaut schwillt an, sie wird angeschwollen.
Oder ich bekomme sogar vielleicht Luftnot.
Dann würde ich sagen, es ist eher eine Allergie.
Ja, eine allergische Reaktion hat das dann.
So würde ich jetzt vielleicht mal, so fällt mir das jetzt ein, vielleicht mal einen Unterschied zu machen.
Also eine Allergie ist etwas Gravierenderes, gravierender mit anderen klinischen Begleitsymptomen.
Ja vielleicht im Mund. Wie gesagt, manche vertragen Kiwi zum Beispiel.
Ja, Kiwi war sehr, sehr modisch und dann plötzlich kriegten Leute von Kiwi ganz starken Ausschlag oder eine ganz starke allergische Reaktion im Gesicht, ein Erythem und was auch immer.
Das würde ich sagen, ist keine Unverträglichkeit, sondern das ist dann schon eine allergische Reaktion.
Das wäre jetzt so meine im Augenblick, so meine Lösung dieser Fragen.